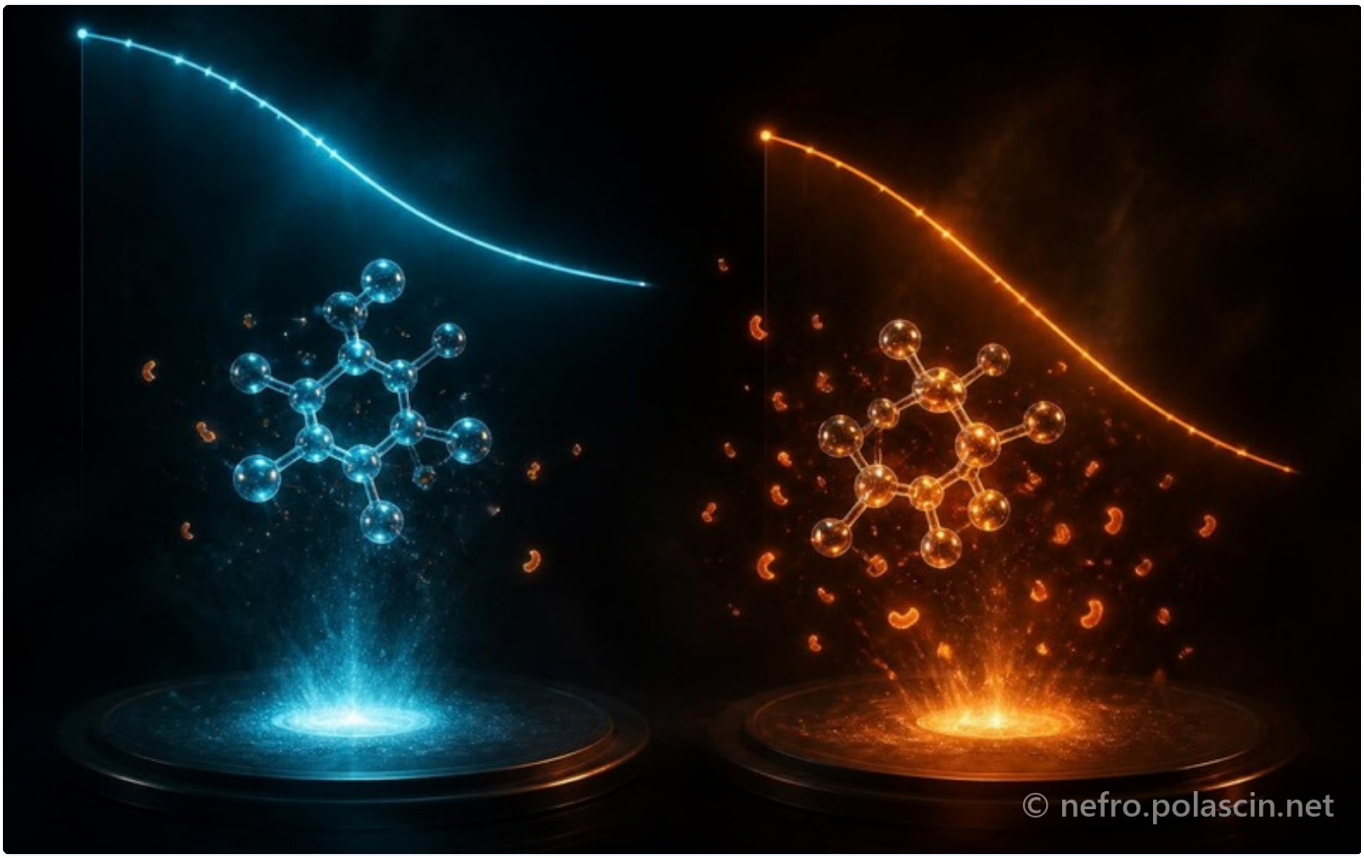
Tirzepatid verzus semaglutid: nižšia mortalita a menej gastrointestinálnych komplikácií

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 11.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Priame porovnanie ukazuje rozdiel v prežívaní aj v znášanlivosti.

Tirzepatid bol vo veľkej observačnej analýze z reálnej klinickej praxe spojený s nižšou celkovou mortalitou a s menším výskytom niektorých gastrointestinálnych nežiaducich udalostí v porovnaní so semaglutidom. Výsledky boli prezentované na Digestive Disease Week 2026 a môžu byť zaujímavé najmä pre diabetológov, internistov, nefrológov, kardiológov a lekárov starajúcich sa o pacientov s obezitou a diabetom 2. typu.

Tirzepatid a semaglutid patria medzi lieky, ktoré výrazne zmenili manažment diabetu 2. typu a obezity. Semaglutid pôsobí ako agonista GLP-1 receptorov, zatiaľ čo tirzepatid je duálny inkretínový agonista s účinkom na receptory GIP a GLP-1. Oba lieky zlepšujú glykemickú kontrolu, podporujú redukciu telesnej hmotnosti a majú potenciálne kardiometabolické benefity.

Nové údaje z veľkej globálnej kohorty však naznačujú, že medzi týmito dvoma molekulami môžu existovať rozdiely nielen v účinnosti, ale aj v bezpečnostnom profile.

Veľká analýza z reálnej klinickej praxe

Výskumníci využili databázu **TriNetX Global Collaborative Network**, ktorá umožňuje analyzovať veľké súbory pacientov z bežnej praxe. Do štúdie zaradili pacientov s nadváhou alebo obezitou a diabetom 2. typu, ktorí začali liečbu buď tirzepatidom, alebo semaglutidom.

Po párovaní podľa propensity score vznikli dve veľké, porovnateľné skupiny:

- **126 971 pacientov** iniciujúcich tirzepatid,
- **126 971 pacientov** iniciujúcich semaglutid.

Pacienti, ktorí užívali oba lieky, boli z analýzy vylúčení. Sledované obdobie sa pohybovalo od 1 dňa do 5 rokov po začiatku liečby.

Autori hodnotili najmä:

- celkovú mortalitu,
- gastroparézu,
- paralytický ileus alebo intestinálnu obštrukciu,
- aspiračnú pneumonitídu.

Nižšia celková mortalita pri tirzepatide

Najvýraznejší rozdiel sa týkal celkovej mortality. V skupine s tirzepatidom bolo zaznamenaných **1182 úmrtí**, zatiaľ čo v skupine so semaglutidom **1998 úmrtí**.

V percentách to predstavovalo:

- **0,9 % pri tirzepatide**,
- **1,6 % pri semaglutide**.

Relatívne riziko bolo **0,59**, čo naznačuje približne **41 % relatívne nižšie riziko celkovej mortality** u pacientov liečených tirzepatidom v porovnaní so semaglutidom.

Treba však zdôrazniť, že ide o observačné údaje. Takýto typ analýzy vie ukázať asociáciu, nie definitívnu kauzalitu. Inými slovami, výsledok neznamená automaticky, že tirzepatid sám osebe „spôsobil“ nižšiu mortalitu. Môžu sa uplatniť aj rozdiely v charakteristikách pacientov, predpisovacej praxi, dávkach, adherencii či dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Menej ileu, črevnej obštrukcie a aspiračnej pneumonitídy

Tirzepatid bol spojený aj s nižším rizikom niektorých gastrointestinálnych komplikácií.

Výskyt paralytického ileu alebo intestinálnej obštrukcie bol:

- **0,9 % pri tirzepatide**,
- **1,0 % pri semaglutide**,

s relatívnym rizikom **0,84**.

Aspiračná pneumonitída bola tiež menej častá pri tirzepatide:

- **0,3 % pri tirzepatide**,
- **0,4 % pri semaglutide**,

s relatívnym rizikom **0,69**.

Riziko gastroparézy bolo medzi skupinami podobné:

- **1,0 % pri tirzepatide**,
- **1,1 % pri semaglutide**,

s relatívnym rizikom **0,95**.

Tieto rozdiely sú numericky malé, ale pri veľmi veľkých populáciách môžu byť klinicky významné, najmä ak ide o pacientov s vyšším rizikom gastrointestinálnych komplikácií, aspiračných udalostí alebo perioperačných problémov.

Prečo je to prekvapivé?

Podľa hlavnej riešiteľky Aasmy Shaukat, MD, z NYU Langone Health v New Yorku bolo prekvapivé, že tirzepatid bol napriek duálnemu inkretínovému mechanizmu spojený s menším počtom nežiaducich udalostí.

Pri inkretínovej liečbe sa často diskutuje spomalenie vyprázdňovania žalúdka, nauzea, vracanie, gastroparéza a potenciálne aspiračné riziko pri anestézii alebo endoskopii. Dalo by sa preto očakávať, že silnejší alebo širší inkretínový efekt môže priniesť viac gastrointestinálnych problémov. Táto analýza však naznačuje opak, aspoň v sledovaných parametroch.

Autori posteru uviedli, že tirzepatid môže v rutinnej praxi ponúkať priaznivejší pomer benefitu a rizika, kombinujúci silnejšie metabolické účinky so zachovanou žalúdočnou motilitou a nižším aspiračným rizikom.

Čo z toho vyplýva pre klinickú prax?

Výsledky môžu podporiť preferenciu tirzepatidu u vhodných pacientov s diabetom 2. typu a obezitou, najmä ak je cieľom výrazná metabolická intervencia a zároveň minimalizácia niektorých gastrointestinálnych rizík.

Pre nefrologickú a internistickú prax je táto téma zaujímavá z viacerých dôvodov. Pacienti s diabetom 2. typu, obezitou, chronickou chorobou obličiek a vysokým kardiovaskulárnym rizikom často potrebujú liečbu, ktorá presahuje samotné zníženie HbA1c. Inkretínová terapia je čoraz viac vnímaná ako súčasť komplexnej kardiorenálno-metabolickej ochrany.

Pri výbere medzi semaglutidom a tirzepatidom však treba zohľadniť:

- indikáciu liečby,
- dostupnosť a úhradu,
- renálnu funkciu,
- kardiovaskulárne riziko,
- telesnú hmotnosť a metabolické ciele,
- predchádzajúcu toleranciu liečby,
- gastrointestinálne príznaky,
- perioperačné alebo endoskopické riziko,
- pacientove preferencie a adherenciu.

Opatrnosť pri interpretácii

Napriek veľkému počtu pacientov má štúdia dôležité limity. Ide o observačnú analýzu z databázy reálnej klinickej praxe, nie o randomizovanú kontrolovanú štúdiu. Aj po párovaní pacientov môže pretrvávať reziduálne skreslenie. Niektoré premenné môžu byť neúplne zachytené alebo nesprávne kódované. Dôležité môže byť aj dávkovanie, dĺžka liečby, adherencia a dôvod výberu konkrétneho lieku.

Samotní autori zdôraznili, že výsledky si vyžadujú potvrdenie v ďalších kohortách a v prospektívnych štúdiách. Plánujú tiež skúmať vzťah medzi dávkou a odpoveďou.

Praktický záver

Táto veľká globálna analýza naznačuje, že **tirzepatid bol v reálnej praxi spojený s nižšou celkovou mortalitou, nižším rizikom ileu alebo črevnej obštrukcie a nižším výskytom aspiračnej pneumonitídy v porovnaní so semaglutidom**. Riziko gastroparézy bolo medzi oboma liekmi podobné.

Tieto výsledky sú klinicky zaujímavé, ale zatiaľ by nemali viesť k zjednodušenému záveru, že tirzepatid je univerzálne lepšou voľbou pre každého pacienta. Skôr podporujú individualizovaný výber liečby, pri ktorom sa hodnotí nielen HbA1c a telesná hmotnosť, ale aj celkový kardiorenálno-metabolický profil, gastrointestinálna tolerancia a konkrétne riziká pacienta.

Zdroj: Spracované podľa Medscape Medical News: „Tirzepatid Tied to Less Mortality and AEs Than Semaglutide“, 2026.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=tirzepatid-verzus-semaglutid-nizsia-mortalita-a-menej-gi-komplikacii · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.